

Parcial reumato 2025

1. En la Artritis Reumatoidea se presentan manifestaciones sistémicas frecuentemente. Marque la que NO corresponde:

- A. Vasculitis reumatoidea
 - B. Queratoconjuntivitis seca
 - C. Adenomegalia
 - D. Derrame pleural
 - E. Enfermedad intersticial pulmonar
-

2. En la Artritis Reumatoidea, la presencia de nódulos reumatoideos se relaciona a:

- A. Tratamiento con leflunomida
 - B. Factor reumatoideo positivo y larga evolución de la enfermedad
 - C. Tuberculosis pulmonar
 - D. Generalmente están adheridos a planos profundos y se relacionan a erosiones articulares
-

3. El tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad (FAMEs/DARMEs) se debe indicar combinado:

- A. Cuando se detectan cambios radiográficos
 - B. Al momento del diagnóstico en cualquier paciente con anticuerpos positivos
 - C. En pacientes que no responden al tratamiento con corticoides
 - D. Cuando el paciente tiene factores de mal pronóstico como valores elevados de CCP, diagnóstico tardío, familiar de primer grado con AR
-

4. En Artritis Reactiva, marque la opción correcta:

- A. Presentación clínica más frecuente es poliartritis de pequeñas articulaciones
 - B. La manifestación dermatológica más frecuente es la queratodermia blenorragica
 - C. Puede evolucionar a formas crónicas y erosivas
 - D. El tratamiento es con antibióticos dirigidos al agente causal
 - E. B + C son correctas
-

5. Las vasculitis sistémicas que afectan pequeños vasos:

- A. Abarcan las vasculitis asociadas a ANCA y las secundarias a LES por depósito de inmunocomplejos
 - B. Se dividen en hipocomplementémicas y normocomplementémicas
 - C. Están asociadas al consumo de tabaco e infección por VHB
 - D. Dentro de este grupo se encuentra la enfermedad de Kawasaki
 - E. A + B son correctas
-

6. En la Panarteritis Nodosa, marque la opción INCORRECTA:

- A. En la anatomía patológica aparece una infiltración de polimorfonucleares en las primeras etapas, luego mononucleares y finalmente necrosis fibrinoide de la pared vascular
 - B. A nivel cutáneo suele presentarse como púrpura palpable asociada a nódulos y ulceraciones a predominio en miembros inferiores
 - C. Es rara la afectación intestinal y testicular
 - D. Las manifestaciones neurológicas incluyen mononeuritis múltiple, ACV, hemorragias y déficits focales
-

7. En Arteritis de Takayasu, los síntomas más frecuentes son:

- A. Cefalea bitemporal y claudicación mandibular
- B. Fenómeno de Raynaud
- C. Se asocia a polimialgia reumática en el 30% de los casos
- D. Claudicación de miembros superiores, diferencia de pulsos radiales y diferencia de la presión arterial en ambos brazos
- E. B + C son correctas

8. Marque la incorrecta en relación a la granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (PEGA):

- A. Tiene una fase prodrómica con asma, rinitis y eosinofilia
 - B. Puede presentar afección gastrointestinal
 - C. A nivel pulmonar se presenta como nódulos que pueden cavitarse
 - D. Es frecuente la afección del sistema nervioso periférico y, en casos graves, del SNC
-

9. La afectación de la arteria temporal en ACG, marque lo incorrecto:

- A. Es una vasculitis necrotizante que afecta solo la arteria temporal superficial
 - B. Se relaciona con palpación dolorosa y pulsatilidad de la misma
 - C. Presenta síntomas generales, se asocia a anemia normocítica normocrómica
 - D. Frecuentemente se relaciona con claudicación mandibular y amaurosis fugaz
-

10. En relación a la miopatía por cuerpos de inclusión (MCI), marque la correcta:

- A. La RNM no tiene ningún rol en el diagnóstico ya que no permite demostrar la infiltración grasa
 - B. Tiene frecuente inicio asimétrico y afecta flexores de los dedos y músculos proximales
 - C. En la biopsia es frecuente el infiltrado inflamatorio perifascicular y perivascular CD4+
 - D. Tiene excelente respuesta al tratamiento con corticoides e inmunosupresores
-

11. En la miopatía necrotizante inmunomediada (MNIM), marque la incorrecta:

- A. Está asociada a la positividad de anticuerpos anti-HMGCoA reductasa solo cuando usa estatinas
 - B. Se caracteriza por un aumento muy marcado de la creatina quinasa (CK) > 50 veces el valor basal y presenta positividad para anticuerpos anti-HMGCoA reductasa, aun si el paciente no usa estatinas
 - C. En la biopsia encontramos abundantes fibras necróticas e infiltrados inflamatorios polimorfonucleares
 - D. Puede presentarse como síndrome paraneoplásico en el contexto de neoplasias malignas
-

12. En el síndrome antisintetasa, marque la opción correcta:

- A. No tiene anticuerpos específicos ni asociados que nos ayuden con el diagnóstico
- B. Presenta síndrome de Raynaud, la afectación pulmonar es frecuente y predomina el infiltrado intersticial
- C. No presenta lesiones cutáneas características

- D. Puede asociarse a lupus o esclerodermia
 - E. B + D son correctas
-

13. De las vasculitis asociadas a ANCA, ¿cuál de las siguientes se puede presentar con hipoacusia?

- A. Granulomatosis con poliangéitis (Ex Wegner)
 - B. Granulomatosis eosinofílica con poliangéitis (ex Churg Strauss)
 - C. Poliangéitis microscópica
 - D. Ninguna presenta afección de oídos
-

14. La fibromialgia es un trastorno de dolor crónico difuso, debilitante y de etiología desconocida.

- A. Marcadores de inflamación elevados en la analítica sanguínea (VES-PCR) y asociado a anemia hemolítica
 - B. Disfunción temporomandibular y síndrome de intestino irritable
 - C. Dolor muscular y elevación de enzimas musculares
 - D. Puede ser secundaria a otras enfermedades como síndrome de Sjogren y LES
 - E. B + C son correctas
-

15. En el tratamiento farmacológico de la fibromialgia, marque lo correcto:

- A. Los miorrelajantes como la ciclobenzaprina tienen eficacia para mejorar los síntomas
- B. Los opiáceos no están indicados para tratamiento de los síntomas dolorosos
- C. Pregabalina y gabapentina son fármacos que más se utilizan en pacientes con síndrome de mismo mecanismo de acción
- D. En la fibromialgia tipo II no es fundamental el tratamiento de las enfermedades asociadas en el manejo de los síntomas

16. En la artritis por depósito de cristales de calcio, marque la opción correcta:

- A. La podagra suele ser la presentación más frecuente
 - B. En las radiografías suelen mostrarse lesiones características que nos permiten hacer diagnóstico diferencial con otras artropatías
 - C. La colchicina es el tratamiento específico de esta enfermedad y debe mantenerse más allá del período agudo
 - D. Es poco frecuente la afección de miembros superiores; nunca afecta hombros y carpos
-

17. En relación al tratamiento de la gota, marque la opción incorrecta:

- A. Los corticoides son una opción aceptable en aquellos pacientes que tienen contraindicación para recibir colchicina o AINES en las crisis agudas
 - B. El inicio de tratamiento con alopurinol o febuxostat debe iniciarse cuando el paciente ha controlado la crisis aguda
 - C. El tratamiento con colchicina no se utiliza para evitar las recurrencias mientras se inicia el tratamiento hipouricemiente
 - D. En los pacientes con falla renal se debe ajustar la dosis de alopurinol
-

18. Dentro de las características compartidas por las EASN se incluyen:

- A. Compromiso axial sobre todo sacroilíaco
- B. Compromiso periférico de predominio oligoarticular
- C. Factor reumatoideo negativo
- D. Compromiso ocular frecuente
- E. Compromiso gastrointestinal en la mayoría de los casos

19. La arteritis de Takayasu se caracteriza por todas las siguientes, excepto:

- A. Es una vasculitis de grandes vasos
 - B. Los vasos más comprometidos son la aorta y subclavias
 - C. Es más frecuente en mujeres jóvenes
 - D. En un porcentaje importante de los casos se asocia a polimialgia reumática
 - E. Frecuentemente no compromete miembros inferiores
-

20. Hombre de 46 años, veterinario, consulta por fiebre ondulante de 10 días (hasta 39°C), dolor testicular derecho, úlceras en miembros inferiores y artritis de rodilla izquierda. El líquido sinovial es inflamatorio. ¿Cuál es la actitud más adecuada?

- A. Lo más probable es que se trate de una artritis reactiva, por lo que se deben dar antibióticos
 - B. La búsqueda de cristales sería de suma utilidad en este caso
 - C. Se debería realizar infiltración de la rodilla
 - D. Profundizaría los estudios biopsiando las lesiones de piel
 - E. Todas son correctas
-

21. Hombre de 40 años con febrícula, astenia, pérdida de peso, secreción nasal purulenta, hemoptisis y púrpura palpable. Creatinina 2,2 mg/dL, ANCA C 1/160, nódulos pulmonares cavitados. ¿Tratamiento más adecuado?

- A. Prednisona y ciclosporina
 - B. AINES y azatioprina
 - C. Prednisona y belimumab
 - D. Prednisona y ciclofosfamida
 - E. AINES y prednisona
-

22. Mujer postmenopáusica en tratamiento con calcio y vitamina D. DMO cuello femoral: Z score -3.1, T score -2.4. Señale la actitud más correcta:

- A. La prueba es normal, suspender calcio y vitamina D
 - B. Mantener tratamiento con calcio y vitamina D
 - C. Recomendar añadir fármaco antirresortivo
 - D. Iniciar tratamiento con teriparatide
 - E. Indicar tiazidas inmediatamente
-

23. Entre las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide seropositiva, señale la que NO se asocia a esa enfermedad:

- A. Uveítis anterior
 - B. Subluxación atlantoaxoidea
 - C. Enfermedad pulmonar intersticial difusa
 - D. Síndrome del túnel carpiano
 - E. Amiloidosis
-

24. Respecto a la radiología de ciertas enfermedades reumáticas, señale la FALSA:

- A. En la artritis reumatoide son características las erosiones óseas marginales
 - B. La artritis psoriásica se caracteriza por la periostitis y más tarde por la calcificación de la entesis
 - C. La artrosis disminuye el espacio articular y presenta osteofitos y esclerosis
 - D. El lupus eritematoso sistémico presenta con frecuencia erosiones óseas
 - E. La sacroileítis bilateral y simétrica es típica de la espondilitis anquilosante
-

25. Mujer de 19 años con poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, fiebre de 39°C, tras caída en bicicleta hace 72 hs. La etiología más probable es:

- A. Bacteriana
 - B. Autoinmune
 - C. Microcristalina
 - D. Viral
 - E. Traumática
-

26. Señale cuál de los siguientes signos radiológicos NO es típico de la espondilitis anquilosante:

- A. Cuadratura de los cuerpos vertebrales
 - B. Calcificación de la entesis aquiliana
 - C. Entesofitos plantares
 - D. Sacroileítis
 - E. Erosiones yuxtaarticulares
-

27. Hombre de 50 años con dolor agudo de rodilla y fiebre leve. También presenta signos inflamatorios en la primera articulación metatarsfalángica. Líquido sinovial con 5000 leucocitos/mm³ y 85% PMN. ¿Qué es lo más correcto realizar?

- A. Artrocentesis para tinción de Gram, cultivo y examen con luz polarizada
 - B. Solicitar ácido úrico e iniciar tratamiento empírico con colchicina y alopurinol
 - C. Solicitar radiografía simple de frente y perfil
 - D. Solicitar 2 hemocultivos e iniciar antimicrobiano con ceftazidima IV
 - E. Indicar corticoide IM y tomar conducta expectante
-

28. Respecto del síndrome de Sjögren, señale la INCORRECTA:

- A. Puede aparecer aislado o asociado a otras enfermedades reumáticas
- B. Cursa con ANA positivo

- C. Los síntomas más comunes incluyen xerostomía y xeroftalmia
 - D. El diagnóstico definitivo se hace con el dosaje de anti-La
 - E. Puede complicarse con nefritis intersticial aguda
-

29. En el síndrome de Churg-Strauss, señale la INCORRECTA:

- A. Debe existir el antecedente de asma o alergias para pensar en el diagnóstico
 - B. Puede debutar como insuficiencia respiratoria aguda
 - C. El dosaje de ANCA-P ayuda al diagnóstico
 - D. Radiológicamente se presenta como consolidación pulmonar de lóbulos superiores
 - E. En la biopsia encontramos infiltrados de predominio eosinófilo
-

30. El síndrome antifosfolípido:

- A. Es más frecuente en hombres
 - B. Es una causa muy común de derrame pleural
 - C. Se debe sospechar en toda mujer con abortos a repetición
 - D. Se diagnostica por biopsia del territorio afectado
 - E. Se trata con aspirina a dosis altas
-

31. Paciente de 72 años, carpintero, con dolores articulares migratorios de 10 años de evolución, sin rigidez matinal. Factor reumatoideo positivo cualitativo, sin signos de inflamación articular. ¿Qué conducta es más apropiada?

- A. Solicitar ecografías de las articulaciones afectadas
 - B. Repetir el factor reumatoideo por método cuantitativo
 - C. Solicitar ANA y anti-CCP
 - D. Desestimar el análisis ya que la clínica no apoya el diagnóstico de AR
 - E. Solicitar un hepatograma para comenzar con metotrexato
-

32. Las siguientes drogas favorecen la osteoporosis, EXCEPTO:

- A. Corticoides
 - B. Anticoagulantes
 - C. Diuréticos de asa
 - D. AINES COX-2 específicos
 - E. Inhibidores de la bomba de protones
-

33. En el tratamiento básico del lupus eritematoso sistémico (LES) se incluyen:

- A. Educación del paciente, AINES, corticoides y metotrexato
- B. Educación del paciente, corticoides, metotrexato e hidroxicloroquina
- C. Educación del paciente, AINES, corticoides e hidroxicloroquina
- D. Educación del paciente, pulsos de corticoides, metotrexato e hidroxicloroquina
- E. Todas son correctas

34. La tríada que caracteriza al síndrome de Reiter incluye:

- A. Sacroileítis, conjuntivitis y cervicitis
- B. Artritis, conjuntivitis y dactilitis
- C. Uveítis, uretritis y artritis
- D. Conjuntivitis, artritis y gastritis
- E. Artritis, uretritis y conjuntivitis

35. Paciente de 66 años que le consulta por cuadro de dolor y debilidad proximal de inicio súbito 2 semanas atrás. Al examen no hay artritis, solo mínimo edema en los dedos. En el laboratorio básico presenta Hb 9, VSG 44. Usted decide:

- A. Solicitar ANCA para buscar vasculitis
- B. Solicitar enzimas musculares pensando en una miopatía
- C. Iniciar tratamiento con metotrexato ya que cumple criterios de AR
- D. Indicar corticoides y ampliar estudios
- E. Realizar un screening para neoplasias

36. El microorganismo más frecuente causante del Síndrome de Reiter es:

- A. *Escherichia coli*
- B. *Shigella*
- C. *Yersinia*
- D. *Proteus*
- E. *Campylobacter*

37. La artritis séptica:

- A. Es mucho más frecuente en pacientes añosos
- B. Se origina generalmente por heridas sobre la articulación afectada
- C. Se sospecha cuando en el líquido sinovial hay más de 50.000 blancos
- D. Suele ser bilateral
- E. Siempre cursa con fiebre y leucocitosis

38. En el screening para usar terapias biológicas no debe faltar:

- A. Serología para Hepatitis B y C
- B. VDRL
- C. Serología para Chagas
- D. Test de embarazo
- E. Todas son correctas

39. Las siguientes son contraindicaciones para el uso de terapias con drogas anti-TNF, excepto:

- A. Insuficiencia renal
- B. Insuficiencia cardíaca
- C. Enfermedad desmielinizante

- D. Antecedente reciente de cáncer
- E. Infección reciente de prótesis

40. Paciente de 65 años con artrosis secundaria de la rodilla derecha por antecedente de fractura en la adolescencia. No tiene limitaciones en otras articulaciones. La radiografía muestra ausencia del espacio articular. Usted le recomienda:

- A. Glucosamina
 - B. Inyecciones de ácido hialurónico
 - C. Cirugía de reemplazo protésico
 - D. Diacereína
 - E. Kinesioterapia
-

41. El líquido sinovial inflamatorio:

- A. Tiene alta viscosidad
 - B. Tiene más de 1000 glóbulos blancos por mm³
 - C. Es de color transparente
 - D. Presenta predominio de polimorfonucleares
-

42. Respecto de la evaluación del líquido sinovial:

- A. Los cristales de urato monosódico tienen forma de aguja o bastón
- B. La visualización de los cristales me permite hacer diagnóstico de gota
- C. Los cristales de pirofosfato de calcio son birrefringentes
- D. La luz polarizada me ayuda a ver mejor los tofos

43. Dentro de los criterios de clasificación del lupus se encuentran los siguientes, excepto:

- A. Psicosis
 - B. Anemia hemolítica
 - C. Fiebre
 - D. Ascitis
-

44. El compromiso cutáneo del LES:

- A. Siempre deja cicatriz en el lugar de la lesión
- B. Está mediado por inmunocomplejos generalmente
- C. Se asocia con la ausencia del anticuerpo anti-Ro
- D. Suele ser una manifestación tardía de la enfermedad

45. Mujer de 42 años con clínica de artralgias, xerostomía asociada. En el laboratorio presenta manos de un ANA positivo, anti-Ro positivo, complemento normal, Factor Reumatoideo 144 UI, hipergammaglobulinemia policlonal. Usted piensa:

- A. Tiene Lupus, debe comenzar con hidroxicloroquina
- B. Sospecha de Artritis Reumatoide, solicita anti-citrulinas y debe iniciar metotrexato
- C. Puede ser Síndrome de Sjögren, solicita biopsia de glándula salival
- D. La clínica no apoya ninguno de los diagnósticos anteriores

46. Mujer de 36 años de edad con antecedente de LES presenta parto a término. Al nacer el bebé se observa que presenta lesiones compatibles con lupus cutáneo subagudo. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Biopsiar las lesiones para definir la conducta terapéutica
- B. Solicitar ecodoppler cardíaco al bebé por el riesgo de bloqueo AV
- C. Hacer estudios de confirmación de LES en el bebé para iniciar tratamiento
- D. Tomar conducta expectante ya que las lesiones suelen desaparecer dentro de los primeros meses

47. Las siguientes drogas favorecen la osteoporosis, excepto:

- A. Anticoagulantes
- B. Diuréticos de asa
- C. AINES COX-2 específicos
- D. Inhibidores de la bomba de protones

48. Un paciente de 72 años, carpintero, le consulta por dolores articulares migratorios de 10 años de evolución, de predominio al final del día, sin rigidez matinal. Le trae un análisis de rutina con VSG de 20 y un factor reumatoideo cualitativo positivo. En el examen usted no detecta inflamación articular. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Solicitar ecografías de las articulaciones afectadas
- B. Repetir el factor reumatoideo pero por un método cuantitativo
- C. Solicitar ANA y Anti-CCP
- D. Desestimar el análisis ya que la clínica no apoya el diagnóstico de AR
- E. Solicitar un hepatograma para comenzar con metotrexato

49. En el síndrome de Churg-Strauss, señale la incorrecta:

- A. Puede debutar como insuficiencia respiratoria aguda
- B. El dosaje de ANCA P ayuda al diagnóstico
- C. Radiológicamente se presenta como consolidación pulmonar de lóbulos superiores
- D. En la biopsia encontramos infiltrados de predominio eosinófilo

50. El síndrome antifosfolípido:

- A. Es una causa muy común de derrame pleural
- B. Se debe sospechar en toda mujer con abortos a repetición
- C. Se diagnostica por biopsia del territorio afectado
- D. Se trata con aspirina a dosis altas